

Лучевые методы используемые для исследования сердечно - сосудистой системы: {

~рентгенологические,

~ангиография:

=УЗИ, КТ:

~ радионуклидное исследования:

~ термография:

}

Для определения состояния просвета и полостей сердца используют: {

~рентгеноскопию:

~рентгенографию:

~рентгенокимографию

=ангиография:

}

Для изучения амплитуды колебаний, стенок камер сердца и сосудов в систолу и диастолу: {

~рентгеноскопия:

~рентгенография:

=рентгенокимография:

~ангиография

}

Для изучения положения, формы, размеров контуров сердца, частоты и глубины пульсации используют: {

=рентгеноскопию:

~рентгенографию:

~рентгенокимографию:

~ангиографию

}

Для изучения выявления камер сердца используют: {

~рентгеноскопию:

~рентгенографию:

~рентгенокимографию:

=ангиографию

}

Из радионуклидных методов для выявления нарушения кровотока с его объёма в системе лёгочной артерии при её тромбозе используют: {

=динамическую сцинтиграфию, с меченым альбумином:

~статическую сцинтиграфию с фосфатом технеция:

~статическую сцинтиграфию с хлоридом таллия:

~статическую сцинтиграфию с МАА - технеция

}

Из радионуклидных методов для выявления зоны некроза при инфаркте миокарда используют: {

~динамическую сцинтиграфию с меченым альбумином:

=статическую сцинтиграфию с фосфатом технеция:

~статическую сцинтиграфию с хлоридом таллия:

~статическую сцинтиграфию с МАА - технецием

}

Из радионуклидных методов для выявления нарушения центральной и периферической гемодинамики используют: {

=динамическую сцинтиграфию с меченым альбумином:

~статическую сцинтиграфию с фосфатом технеция:

~статическую сцинтиграфию с хлоридом таллия:

~статическую сцинтиграфию с МАА - технецием

}

Из радионуклидных методов для выявления тромба в камере сердца используют: {

=динамическую сцинтиграфию с меченым альбумином:

~статическую сцинтиграфию с фосфатом технеция:

~статическую сцинтиграфию с хлоридом таллия:

~статическую сцинтиграфию с МАА - технецием

}

Из способов УЗИ при исследовании ССС для выявления гипертрофии миокарда используют: {

=эхокардиографию, УЗ - сканирование:

~доплерографию

~магнитно-резонансная томография

~рентгенокимография

}

Для определения размеров полостей сердца, просвета сосудов используют: {

=эхокардиографию УЗ - сканирование:

~коронарография

~доплерографию

~рентгенография

}

Для определения скорости кровотока по сосудам применяется : {

=доплерография

~позитронно-эмиссионная томография

~КТ

~ ангиография

}

Из радионуклидных способов при исследовании ССС статическая сцинтиграфия с фосфатом технеция используется для: {

выявления нарушения лёгочного кровотока и его объёма в системе лёгочной артерии при её тромбозе:

=выявление зоны некроза при инфаркте миокарда:

~выявление нарушений центральной гемодинамики

~выявление нарушений периферической гемодинамики:

~выявление тромба в камере сердца

}

Термографию при исследовании ССС используют с целью: {

=подтверждение воспалительного процесса в венах:

~выявление зон сниженного кровообращения при окклюзии артерий:

~выявление токсикоаллергического воздействия на сосуды при хроническом тонзиллите:

~правильно всё перечисленное

}

КТ при исследовании сердца и сосудов используют с целью определения: {

~гипертрофии миокарда и расширения полостей:

~аневризм сердца, тромбов в полостях и внутриполостных образований:

~состояния просвета сосудов

=правильно всё перечисленное

}

Правое предсердие занимает: {

~3 дугу левого контура:

~4 дуга левого контура:

~верхняя дуга правого контура:

=нижняя дуга правого контура

}

Восходящая аорта, верхняя полая вена занимает: {

~1 дугу левого контура:

~2 дугу левого контура:

~4 дуга левого контура:

=верхняя дуга правого контура:

}

Дуга аорты занимает: {

=1 дугу левого контура:

~4 дуга левого контура:

~верхняя дуга правого контура:

~нижняя дуга правого контура

}

Ушко левого предсердия, лёгочный ствол занимает: {

=3 дуга левого контура:

~4 дуга левого контура:

~верхняя дуга правого контура:

~нижняя дуга правого контура

}

Левый желудочек занимает: {

~1 дугу левого контура:

~2 дугу левого контура:

=4 дугу левого контура:

~3 дугу левого контура:

}

Глубокая выемка между 1 и 4 дугами левого контура, удлинение 4 дуги, увеличение 1 дуги, смещение правого атриовазального угла книзу {

~митральная конфигурация:

=аортальная конфигурация:

~трапециевидная конфигурация

~трапециевидная конфигурация

}

Равномерное увеличение сердца в обе стороны, отсутствие чётного разделения контуров на дуги: {

~митральная конфигурация:

~аортальная конфигурация:

=трапециевидная конфигурация

~шаровидная конфигурация

}

Удлинены и более выпуклы 2 и 3 дуги левого контура, правый атриовазальный угол смещён кверху {

=митральная конфигурация:

~аортальная конфигурация:

~трапециевидная конфигурация

~желудочковая конфигурация

}

2-3 дуга левого контура образованы {

~правым предсердием, левым предсердием

~дугой аорты, легочным стволом

=ушком левого предсердия, лёгочным стволом:

~левым желудочком, левым предсердием

}

Верхняя дуга правого контура образована: {

~правым предсердием:

=восходящей аортой (верхней поллой веной):

~дугой аорты:

~дугой аорты:

}

Нижняя дуга правого контура образована: {

=правым предсердием:

~восходящей аортой:

~дугой аорты:

~ушком левого предсердия, лёгочным стволом:

}

Митральная конфигурация характеризуется {

=удлинением и выпуклостью 2 и 3 дуги левого контура:

~равномерным увеличением сердца в обе стороны с потерей чёткого разделения контуров на дуги:

~глубокой выемкой между 1 и 4 дугами левого контура:

~глубокой выемкой между 1 и 3 дугами левого контура:

}

Аортальная конфигурация характеризуется: {

~удлинением и выпуклостью 2 и 3 дуги левого контура,
равномерным увеличением сердца в обе стороны с потерей чёткого
разделения контуров на дуги;

=глубокой выемкой между 1 и 4 дугами левого контура,
удлинением 4 дуги, увеличением 1 дуги, смещением правого атриовазального
угла книзу;

~глубокой выемкой между 1 и 4 дугами левого контура,
удлинением 4 дуги, увеличением 1 дуги, смещением правого атриовазального
угла кверху

~глубокой выемкой между 1 и 3 дугами левого контура,
удлинением 3 дуги, увеличением 1 дуги, смещением правого атриовазального
угла кверху

}

Трапецевидная конфигурация характеризуется: {

~удлинением и выбуханием 2 и 3 дуги левого контура;

=равномерным увеличением сердца в обе стороны с потерей чёткого
разделения контуров на дуги;

~глубокой выемкой между 1 и 4 дугами левого контура, удлинением 4 дуги,
увеличением 1 дуги, смещением правого атриовазального угла книзу;

~глубокой выемкой между 1 и 4 дугами левого контура, удлинением 4 дуги,
увеличением 1 дуги, смещением правого атриовазального угла книзу

}

Способы лучевого исследования для оценки морфологии сердца и сосудов: {

~рентгеноскопия, рентгенография, томография

~КТ ангиография, томография

~рентгенокимография

=правильно все

}

При статической сцинтиграфии сердца с фосфатом технеция выявляется очаг
повышенного: хлоридом таллия - пониженного накопления, что характерно
для {

~воспаления вены

~аневризмы сосуда

=инфаркта миокарда

~нарушения кровообращения вследствие стеноза сосудов

}

При термографии в области поверхностной вены бедра отмечается гипертермия
что характерно для: {

=воспаления вены

~аневризмы сосуда
~инфаркта миокарда
~хронической ишемической болезни (ХИБС)
}

При термографии в зоне кровоснабжения артерией голени отмечается гипотермия, что характерно для: {

~воспаления вены
~инфаркта миокарда
~хронической ишемической болезни сердца (ХИБС)
=нарушения кровообращения вследствие стеноза сосуда
}

На ангиографии отмечается ограниченное расширение сосуда, что характерно для: {

~воспаления вены
=аневризмы сосуда
~хронической ишемической болезни сердца (ХИБС)
~нарушения кровообращения вследствие стеноза сосуда

На ангиограмме отмечается ограниченное сужение сосуда, что характерно для: {

~аневризмы сосуда
~инфаркта миокарда
~хронической ишемической болезни сердца (ХИБС)
=нарушения кровообращения вследствие стеноза сосуда
}

Для стеноза митрального отверстия, недостаточности митрального клапана характерно: {

=митральная форма сердца
~аортальная форма сердца
~трапецевидная форма сердца
~трапецевидная форма сердца
}

Для миокардита, перикардита характерно: {

~митральная форма сердца
~аортальная форма сердца
=трапецевидная форма сердца
~трапецевидная форма сердца
}

Для стеноза аортального отверстия, недостаточности аортального клапана, гипертонической болезни характерна: {

~митральная форма сердца
=аортальная форма сердца
~трапецевидная форма сердца
~трапецевидная форма сердца

}

При КТ сердца получены признаки в виде утолщения и уплотнения перикарда, расширения полости перикарда, плотность содержимого перикарда соответствует жидкости, что характерно для: {

~аневризмы сердца:

~тромбированной аневризмы сердца:

~образования в области сердца

=экссудативного перикардита

~аневризмы аорты

}

При КТ сердца с контрастированием выявлено локальное истончение с выбуханием наружного контура сердца, что характерно для: {

=аневризмы сердца

~тромбированной аневризмы сердца

~образования в полости сердца

экссудативного перикардита

}

При КТ сердца получены признаки в виде ограниченного расширения аорты, характерно для: {

~аневризмы сердца

~образования в полости сердца

экссудативного перикардита

=аневризмы аорты

}

При КТ сердца с контрастированием выявляется дефект наполнения полости сердца, что характерно для: {

~аневризмы сердца

~тромбированной аневризмы сердца

=образования в полости сердца

~аневризмы аорты

}

При ультразвуковом - сканировании выявляются признаки в виде утолщения и уплотнения стенки перикарда, расширения полости перикарда, неоднородности структуры содержимого, что характерно для: {

~поражения клапанного аппарата

~стеноза артерии

=экссудативного перикардита

~венечных артерии

}

При доплерографии отмечается снижение амплитуды и увеличение длительности эхоимпульса над артерией, что характерно для: {

~поражения клапанного аппарата сердца

=стеноза артерии

~экссудативного перикардита

~атрезия трехстворчатого клапана
}

Назовите основные инвазивные методы лучевого исследования сердца: {

~%50%рентгенография
~%50%УЗИ
~%-100%ангиокардиография
~%-100%вентрикулография
}

Какое положение занимает сердце у лиц гиперстенической конституции: {

~вертикальное
~косо расположенного овала
=горизонтальное
~декстрапозиция
}

Какой метод считается ведущим среди неинвазивных методов исследования сердца и сосудов? {

~флюорография
~рентгеноскопия
=УЗИ
~ангиография
}

Что лежит в основе двигательной субтракционной ангиографии /ДСА {

~введение контрастного вещества через сосудистой катетер;
~введение контрастного вещества в желудочки сердца;
=трансформация рентгеновского изображения в видеоизображении с цифровым кодированием
~исследование циркуляции крови и кровоснабжение тканей
}

Укажите возможности УЗИ /сонографии/ сердца: {

~определяет размах систолических движений регистрируемой анатомической структуры;
~изучение скорости движения крови: направление, характер течения;
~наблюдать на экране монитора за движением стенок сердца и клапанов;
=правильно всё выше перечисленное
}

Что можно определить применяя равновесную вентрикулографию в радионуклидной диагностике: {

~миокардиальный кровоток;
~динамику изменения полостей сердца на протяжении сердечного цикла;
=насосную функцию сердца и характер движений стенок сердца
~тетрада Фалло
}

Сколько дуг по правому контуру сердечно сосудистой тени в прямой

проекции: {
=2;
~3;
~4;
~5
}

Какие отделы образуют, правый контур сердечно сосудистой тени в прямой проекции:

~%-100%левое предсердие;
~%50%восходящая аорта;
~%50%правое предсердие;
~%-100% аорта;
}

Какие отделы образуют левый контур сердечно сосудистой тени: {

~%-100%восходящая аорта;
~%50%легочная артерия;
~%50%нисходящая аорта;
~%-100%левое предсердие;
}

Сколько дуг по левому контуру сердечно сосудистой тени в прямой проекции:

~2;
~3;
=4;
~5
}

В рентгенографии сердца приняты следующие проекции: {

~прямая;
~боковая;
~косые-левая и правая;
=правильно все
}

К радионуклидным методам исследования сердца относятся: {

~%50%равновесная вентрикулография;
~%50%перфузионная сцинтиграфия;
~%-100%рентгеноскопия;
~%-100%УЗИ;
}

К неинвазивным методам относится: {

~%33.33333%рентгенография и рентгеноскопия;
~%-100%аортография;
~%33.33333%УЗИ;
~%33.33333%компьютерная рентгеновская и магнитно-резонансная-
томография;
}

Большой круг кровообращения состоит из: {

- =левый желудочек, аорта, правое предсердие;
- ~правый желудок, легочная артерия, левое предсердие;
- ~левый желудочек, легочная артерия, правое предсердие
- ~правое предсердие, легочная артерия, левый желудочек

}

Митральная форма сердца наблюдается при: {

- =недостаточности и стенозе митрального клапана;
- ~недостаточности и стенозе аортальных клапанов;
- ~недостаточности и стенозе клапанов легочной артерии
- ~незаращение боталлова порока

}

При митральной форме сердца наблюдается: {

- ~50%увеличение и выбухание 2 и 3 дуги левого контура сердца
- ~50%талия сердца сглажена, правый атриовазальный угол смещен вверх
- ~100%талия сердца подчеркнута
- ~100%увеличение и взбухание 1 и 4 дуги левого контура

}

Изменение положения сердца в грудной клетке наблюдается при: {

- ~выпотном плеврите
- ~диафрагмальной грыже и опухолях
- ~гипертонической болезни
- =пневмотораксе

}

Изменение формы сердца наблюдается при: {

- ~митральных порока
- ~выпотном перикардите
- ~аортальных пороках
- =правильно все

}

Лучевая ангиография исследует: {

- =сосуды
- ~полости
- ~морфологию органа
- ~секвестр

}

Для исследования вен нижних конечностей используют: {

- ~импедансную плетизмографию
- ~рентгеновскую флебографию
- ~УЗИ

=все ответы правильны

}

Рентгенологически аортальная форма сердца проявляется:

=выраженной талией сердца

- ~увеличением и выбуханием 2 и 3 дуги слева
- ~увеличением и выбуханием 1 и 4 дуги слева
- ~увеличением и выбуханием 1 дуги справа

Артериальная гипертензия в малом круге кровообращения может наблюдаться:

- {
- ~при гипертонической болезни
- ~при тетраде Фалло
- =при открытом артериальном протоке
- ~экссудативном перикардите
- }

Уменьшение диаметра аорты характерно: {

- ~для недостаточности аортального клапана
- ~для недостаточности митрального клапана
- ~для атероматоза аорты
- =для стеноза левого атрио-вентрикулярного отверстия
- }

Увеличение амплитуды сокращений сердца характерно: {

- =для аортальной недостаточности
- ~для выпотного перикардита
- ~для миогенной дилатации
- ~для миокардиопатии
- }

Пульсация корней легких характерна: {

- ~для недостаточности аортального клапана
- =для дефекта межпредсердной перегородки
- ~для стеноза легочной артерии
- ~для тетрады Фалло
- }

Увеличение правого предсердия наблюдается: {

- ~при стенозе устья аорты
- =при стенозе правого атрио-вентрикулярного отверстия
- ~при недостаточности аортального клапана
- ~при дефекте межжелудочковой перегородки
- }

Обязательным увеличением левого предсердия сопровождается: {

- ~коарктация аорты
- ~триада Фалло
- =митральный стеноз
- ~аневризма аорты
- }

При аортальном пороке (стенозе устья) : {

- ~аорта не изменена
- ~диффузное расширение аорты

=локальное расширение восходящего участка

~аорта узкая

}

При аортальном пороке (стенозе устья) наблюдается: {

~пульсация аорты низкой амплитуды

=локальное увеличение амплитуды пульсации восходящего участка аорты

~пульсация не изменена

~пульсация отсутствует

}

Акинетическая зона в области третьей дуги (прямая проекция) может наблюдаться: {

~при митральной недостаточности

=при тромбозе ушка левого предсердия

~при аортальном стенозе

~при аортальной недостаточности

}

Западение второй дуги по левому контуру сердца наблюдается: {

~при дефекте межпредсердной перегородки

~при открытом артериальном пороке

~при митральной недостаточности

=при стенозе легочной артерии

}

Венозный застой в малом круге кровообращения характерен: {

~для дефекта межпредсердной перегородки

~для болезни Аэрза

~для "легочного сердца"

=для стеноза левого атрио-вентрикулярного отверстия

}

Увеличение левого желудочка наблюдается: {

~при митральном стенозе

~при триаде Фалло

=при открытом артериальном протоке

~при трикуспидальном стенозе

}

Контрастное вещество, введенное в левый желудочек, контрастирует одновременно правый желудочек и аорту: {

~при открытом артериальном протоке

~при аномалии Эбштейна

~при триаде Фалло

=при дефекте межжелудочковой перегородки

}

Выраженная активная (самостоятельная) пульсация корней легких наблюдается: {

~при тетраде Фалло

~при врожденном стенозе устья аорты
=при дефекте межпредсердной перегородки
~при стенозе легочной артерии
}